

09 - ANATOMIE FMPM ANATOMIE VAGIN ET VULVE PR. ABOULFALAH

Bonjour tout le monde, ce cours est consacré à l'anatomie du vagin et de la vulve. Tout d'abord, un élément très très important représenté par le diaphragme pelvien. Cet élément anatomique est très très important parce qu'il va séparer la grande cavité abdominopelvienne du périnée.

Il est appelé aussi plancher pelvien et constitué essentiellement par les muscles releveurs de l'anus. Le vagin est un canal aplati en ventreau caudal. Elle est souple, élastique et contractile.

Elle s'étend du col de l'utérus jusqu'à la vulve. Elle est oblique en caudale et ventrale. Elle est de longueur de 8 à 10 cm.

Sa compliance est maximale lors de l'accouchement et qui va diminuer après la ménopause. Son extrémité crâniale, appelée fornix du vagin, est insérée sur le col utérin selon une ligne oblique en caudale et ventrale. Cette insertion détermine autour de la partie intravaginale du col utérin, du cul de sac, le cul de sac ventral, le cul de sac dorsal et le cul de sac latéral.

Le cul de sac ventral est à peine marqué alors que le cul de sac dorsal est très profond. L'extrémité inférieure du vagin forme l'orifice vaginal qui contribue à la formation du vestibule vulvaire. Cet orifice est fermé incomplètement chez la femme vierge par une membrane muqueuse perforée, appelée l'hymen.

Lors du premier rapport sexuel, l'hymen se déchire, entraînant une légère hémorragie et laissant persister par la suite des résidus appelés les caroncules humaineaux. Deux faces, une face ventrale et une face dorsale à décrire, ont contact l'une de l'autre. La face ventrale présente au niveau de l'orifice vaginal une saillie plus ou moins nette appelée la carinae uretrale.

Sa surface interne présente sur chaque paroi ventrale et dorsale d'une saillie longitudinale médiane appelée les colonnes du vagin. La colonne ventrale est elle seule, se divisant en deux branches à la hauteur du col visical pour délimiter un triangle appelé triangle vaginal de Paulik et qui correspond à la zone la plus érogène du vagin. Elle est parcourue par des plis transversaux nommés rides vaginales.

Quels sont les rapports du vagin? Les rapports antérieurs au ventral, tout d'abord il y a le trigone visical par l'intermédiaire du septum visico-vaginal et il y a l'urètre, rapport très très important qui explique la possibilité d'avoir des fistules de communication entre l'appareil urinaire et génital et puis par l'envahissement des tumeurs. En postérieur, en dorsale, il y a le cap du rectum par l'intermédiaire du cul de sac rectogénital de Douglas et puis le canal anal par l'intermédiaire du noyau fibreux central du périnée appelé aussi centre tendineux du périnée. En latéral, on va trouver le paramètre et le paravagin ou paraservix.

La vascularisation artérielle provient de l'artère vaginale longue qui est une collatérale du tronc

ventral de l'artère iliac interne ou l'hypogastrique. Il y a les artères visico-vaginales qui sont des collatérales de l'artère utérine dans sa portion sous-ligamentaire après avoir croisé l'urètre. Les veines sont satellites des artères et vont rejoindre la veine iliac-interne.

Puis le drainage lymphatique se fait vers les noeuds iliac-interne et iliac-externe ainsi que les noeuds inguinaux. Pour l'anatomie de la vulve, on va décrire les éléments qui constituent la vulve, à savoir le mont du pévis et puis les formations labiales, c'est-à-dire les grandes lèvres et les petites lèvres, l'espace interlabial, les différents organes érectiles, les glandes vulvaires pour voir par la suite la vascularisation de la vulve et les applications pratiques de l'anatomie. La vulve s'étend devant et sous le pévis sur mont du pévis.

C'est un relief triangulaire à sommet inférieur situé devant la symphyse pupienne et recouvert de poils et constitué par un amas cellulaire à du peu plus ou moins important. Les grandes lèvres, ce sont deux replis cutanés qui délimitent la fente vulvaire. Elle mesure en moyenne 8 cm de long pour 1,5 cm de large.

Sa face externe est plissée, de couleur foncée et pileuse. Elle est séparée de la face interne des cuisses par le sillon génitofémoral. Sa face interne est lisse, rosée et glabre.

Elle est séparée des petites lèvres par le sillon interlabial. Les deux extrémités ventrales des grandes lèvres se réunissent pour former la commissure ventrale qui se perd dans le mont du pévis. Les deux extrémités dorsales forment la commissure dorsale qui présente une légère dépression, la faussette des vestibules du vagin ou fauchette vulvaire.

Les petites lèvres sont rosées, lisses et dépourvues de poils. Leur face externe est séparée des grandes lèvres par le sillon interlabial. La face interne des deux petites lèvres délimite le vestibule.

Leurs extrémités ventrales et crâiales se dédoublent en deux replis. Un repli ventral qui passe au-dessus du clitoris pour former le prépuce ou le capuchon clitoridien. Et un repli dorsal qui se fixe au-dessous du clitoris pour former le frein du clitoris.

Leurs extrémités dorsales et caudales se réunissent pour former le frein vulvaire. Le vestibule, c'est la dépression délimitée par la face interne des petites lèvres et le clitoris. De bas en haut, on va rencontrer l'orifice vaginal qui est fermé chez la femme vierge par l'hymen.

L'hymen est séparé des petites lèvres par le sillon vestibulaire. Dans ce sillon, à la hauteur de 5 heures et 7 heures, s'ouvre l'orifice des glandes vestibulaires majeures qui sont appelées aussi les glandes de Bartholin. L'homéa urethrale située au-dessus de la caréna urethrale du vagin et de partie d'autre du homéa s'ouvre l'orifice des glandes para-urethrales de Skene.

Le clitoris, organe érectile de la femme, correspond au corps caverneux du pénis chez l'homme. Elle est donc l'objet d'érection. En moyenne, il mesure 2,5 cm de long sur 6 mm de diamètre.

Elle est formée d'un corps terminé par une extrémité conique qui est mousse. C'est le gland du clitoris. Les bulbes vestibulaires sont des analogues aux corps spongieux chez l'homme et qui se sont dédoublés par l'interposition du vagin qui les entoure en partie.

Ils sont situés dans la profondeur des petites lèvres, depuis le clitoris en avant et en haut, jusqu'aux orifices des glandes vestibulaires majeures en arrière et en bas. Ils sont fixés au bassin par les muscles qui se prolongent dans les petites lèvres, en particulier les muscles bulbo-spongieux. Les glandes vulvaires contribuent tous à la lubrification de la vulve.

Elles comprennent les glandes vestibulaires mineures situées à la surface des formations labiales, les glandes para-orétrales, de part et d'autre du méa-orétral, et puis les glandes vestibulaires majeures, ou les glandes de Bartholin, qui souvent font des infections à ce niveau-là et sont appelées partholinites ou abcès de Bartholin. Là, sur ce schéma, on voit les différents constituants de la vulve. Le clitoris, le méa-orétral, les grandes lèvres et les petites lèvres.

Et on voit ici les glandes de Bartholin qui s'ouvrent à ce niveau-là. Là, sur ce schéma en position gynécologique, on voit le mondubibis, le clitoris, le méa-orétral, les grandes lèvres, les petites lèvres et le vestibule. Concernant la vascularisation de la vulve, la vascularisation artérielle, on distingue deux territoires.

Un antérieur qui est vascularisé par la pudendale externe supérieure et inférieure, qui sont les deux branches de l'obturatrice. Et un territoire postérieur dont la vascularisation est assurée par les branches de la hanteuse interne. Les veines, un territoire antérieur, le mondubibis, c'est la partie antérieure des grandes et des petites lèvres.

Le retour venant est assuré par la veine pudendale externe. Et le reste de la vulve, le retour venant est assuré par la veine pudendale interne et par la saphène interne. Le drainage lymphatique est assuré par les gonglions inguinaux superficiels et profonds, et puis vers les gonglions iliaques externes.

L'énervation provient du plexus supogastrique, qui donne le nerf hanteux interne, qui donne le nerf pudendale. Les aspects pratiques, donc, au moment de l'accouchement, pour favoriser l'accouchement, on peut faire ce qu'on appelle l'épisiotomie, c'est de couper à ce niveau-là. Et on regarde ici l'ampliation musculaire très très importante qui se fait pour livrer passage au fœtus au moment de l'accouchement.